

基于《黄帝内经》“重阳”思想探讨类风湿关节炎论治

孟乐乐¹, 张雪莹², 孙立³✉

¹ 贵州中医药大学 骨伤学院, 贵阳 550025; ² 贵州中医药大学 第一临床医学院, 贵阳 550025; ³ 贵州省人民医院 骨科, 贵阳 550002

摘要 类风湿关节炎是骨科常见病, 现代医学认为本病的发生主要由于急性或者慢性结缔组织炎症引起, 而引起本病的原因目前还不明确。中医治疗多以“痹证”论治, 关于本病论述最早见于《黄帝内经》, 其中对类风湿关节炎的病因病机、症状、治疗、转归预后等诸多方面进行了一些论述, 其中关于意象思维、以阳为重、法天则地等思想对类风湿关节炎的论治提供了一些理论依据。本文以《黄帝内经》中关于类风湿关节炎的认识和一些理论观点为基础, 基于“重阳”思想对类风湿关节炎的论治体系进行一些归纳整理, 通过临床案例分析, 以期对类风湿关节炎的临床治疗提供参考。

关键词 黄帝内经; 痹证; 类风湿关节炎; 重阳思想

中图分类号 R593.22

DOI:10.15991/j.cnki.41-1361/r.2025.05.002

Discussion on the treatment of rheumatoid arthritis based on the idea of “emphasizing the Yang” in the Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine

MENG Lele¹, ZHANG Xueying², SUN Li³✉

¹ Guizhou University of Traditional Chinese Medicine, College of Orthopedics and Traumatology, Guiyang 550025, CHN;

² Guizhou University of Traditional Chinese Medicine, First Clinical Medical College, Guiyang 550025, CHN; ³ Guizhou Provincial People’s Hospital, orthopedic surgery, Guiyang 550002, CHN

Abstract Rheumatoid arthritis is a common disease and modern medicine believes that the occurrence of this disease is mainly due to acute or chronic inflammation of connective tissues, and the cause of this disease is still unclear. Chinese medicine treatment is mostly based on “paralysis”, and the earliest exposition of paralysis is mainly found in the “Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine”, which provides some theoretical bases for the treatment of paralysis in terms of its etiology, mechanism, symptoms, treatment, prognosis and other aspects. In this paper, based on the understanding of paralysis and some theoretical views in Huangdi Neijing, we summarize and organize the treatment system of paralysis based on the idea of “emphasizing the Yang”, and through clinical cases, the treatment system of paralysis is summarized. This paper summarizes and organizes the treatment system of paralytic syndrome based on the idea of “emphasizing the Yang”, and shares the clinical cases in order to provide reference for the clinical treatment of rheumatoid arthritis.

Key words Huangdi Neijing; paralysis; rheumatoid arthritis; emphasizing the Yang thought

收稿日期: 2025-04-20

基金项目: 国家自然科学基金(81960401)

作者简介: 孟乐乐(1993—), 男, 硕士, 主治医师。研究方向: 骨关节及相关疾病。

✉ 通信作者, E-mail: 280457782@qq.com

类风湿关节炎(Rheumatoid arthritis, RA)是骨科的常见疾病,以慢性的关节滑膜炎、血管翳形成及关节面的破坏为主要临床表现。现代医学认为,本病的发生主要由于免疫紊乱引起的炎症反应,是一种主要影响关节和关节周围软组织的系统性的自身免疫疾病^[1]。本病的发病机制目前还不明确,有研究指出,本病具有一定的遗传倾向,类风湿关节炎患者的近亲患病风险是普通人群的2到5倍。此外,在遗传易感患者中,常见的环境因素,比如,吸烟、病毒、肥胖、环境以及人体微生物群的改变都会诱发类风湿关节炎的发生^[2]。大多数患者初始表现为一个或几个关节的疼痛和肿胀,多隐匿性发病,然后逐渐加重,呈对称性的多关节病变,其中以上下肢的小关节受影响最大,逐渐发展到肩、肘、膝、踝等大关节,常表现为滑膜关节的疼痛、肿胀和僵硬。类风湿关节炎容易反复发作,难以治愈,随着病情的进展,除了骨骼肌肉关节的症状和疲劳、虚弱、厌食、体重减轻和低热等身体机能下降外,在疾病发展的后期常常会累及心脏等多器官。心血管疾病、感染、抑郁症等并发症也增加了患者的负担^[3]。免疫治疗是类风湿的重要基石,在规范化治疗中不可或缺。目前,虽然Janus激酶抑制剂等靶向药物及生物制剂在类风湿关节炎的治疗中取得了一定的进展。但目前类风湿关节炎的治疗主要还是以甲氨蝶呤等抗风湿及激素类药物的应用。在类风湿关节炎的长期治疗中,感染、骨质疏松等药物应用带来的不良反应也给患者的生活质量造成了巨大影响^[4]。

中医药具有悠久的历史,类风湿关节炎在中医古代典籍中并未提及。根据类风湿关节炎的发病机制和临床表现,可以“尪痹”、“痹证”、“历节”等病论治。本病初起多因素体亏虚、外感风寒湿热之邪,风、湿、寒等致病因素侵袭四肢,以至经络不通、肢体不荣,引起关节部位的疼痛、肿胀和功能障碍。若是迁延日久,风寒湿邪逐渐入内,郁而化热,耗伤气阴,疾病后期多形成气阴两虚、邪气阻络之证^[5]。中医药辨证用药治疗风湿性关节炎的效果显著,并且绿色、安全、应用灵活、副作用少。为了进一步挖掘经典理论中对风湿性关节炎的论治描述,本文从《黄帝内经》入手,基于“重阳”理论总结其对风湿性关节炎的认识和治疗,希望能为风湿性关节炎的治疗提供一定的临床参考。

1 “重阳”思想探析及内涵

阴阳学说是中国古代重要的哲学思想之一。

《易传·系辞上》指出:“一阴一阳之谓道”,其中“道”指事物的本质以及运动的规律和方法,以朴素的矛盾法则认为事物具有两面性并且是不断变化的,“阴”“阳”,相反相成,相互斗争,相互推进,由此构成事物的本质及其运动的规则。而在“阴阳”二气中,阳气的作用尤为突出,《易传·系辞上》:“天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣”,又指出:“大哉乾元、万物资始,乃统天”^[6]。在道家思想中,其中“乾”多引申为天,天属“阳”,为万物产生的根源,是物质产生的原动力;“坤”多引申为地,地属“阴”,从属于天,根据天的运动变化而变化。这些思想不只指出阴阳之间的对立统一和不可分割,也指出在事物的运动变化中“阳气”的重要作用。

受古代哲学思想的影响,中医古典理论著作中也极其注重阴阳在人体中的重要作用。根据中医基础理论中的整体观念和“天人一体观”,把宇宙万物的发展规律与人体相统一,认识到阴阳理论不仅是事物发展的规律,也是人体疾病发生发展的基本规律。作为中医学四大经典著作之一,被后世尊为“医家之宗”的《黄帝内经》,是我国现存最早、影响最大的一部医书,奠定了中医学的基础,其中也深受阴阳理论的影响。《素问·阴阳应象大论》指出:“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始”。其中不仅指出阴阳是宇宙间一切事物普遍存在及变化运动的根本规律,更是万物生长变化的根本;并且又指出:“天地者,万物之上下也;阴阳者,血气之男女也;左右者,阴阳之道路也;水火者,阴阳之征兆也;阴阳者,万物之能始也”,对阴阳理论做了进一步形象具体化的比喻和论述^[7]。

综其论述不难发现,其中对“阳气”的功能和作用更为看重。《素问·方盛衰论》指出:“阴阳并交者,阳气先至,阴气后至”,阴阳之气互根互藏,互济交通,阳气先至,阴气后至,认为阳气是推动人体生命活动的力量,如果缺少阳气的推动,则无法维持正常的生命活动。“阳气”在人体生命活动中的体现,贯穿整个生命活动的始终,人体的生长发育、疾病的发生和转归无不体现出“阳气”的重要性。《素问·上古天真论》中的:“女子七岁,肾气盛,齿更发长,……三七,肾气平均,故真牙生而长极。……丈夫八岁,肾气实,发长齿更。……三八,肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极。……五八,肾气衰,发堕齿槁。六八,阳气衰竭于上,面焦,发鬓颁白”。其中所讲到的肾气指肾精所化生之气,也称肾阳、元阳、真阳、真火,其对人体有温煦、激发、兴奋、封藏和制约阴寒等作用,人体的正常生理状态多由阳气主导,不仅促进

人体精气血津液的生成和转化,推动人体的新陈代谢,并且肾阳的盛衰变化推动人体的生长发育和衰老过程,在维持正常的生命活动中具有举足轻重的作用。正如《素问·生气通天论》中所载:“阴平阳秘,精神乃治,阴阳离决,精气乃绝”,阴气平顺,阳气固守,阴阳双方相互制约调节而维持相对平衡,是正常生命活动的基础。《素问·生气通天论》中指出:“阳气者,若天与日,失其所,则折寿而不彰”,指出人体的阳气就如天上的太阳一样重要,如果不能正常的发挥作用,就会影响到人体的健康^[8]。也正如后世医家郑钦安指出:“可知阳者,阴之主也,阳气流通,阴气无滞”,体现出阳气对人体生命活动的主导作用,人体阴阳在“阳主阴从”的主导下保持平衡协调,才能维持健康的状态^[9]。这些理论充分体现阳气在人体生命活动的重要性,不仅为临床治疗提供重要的理论依据,也指导我们在生活中要法于阴阳、合于术数、顺应自然,注重阳气的保护。正如《黄帝内经·生气通天论》中所讲:“苍天之气,清静则志意治,顺之则阳气固,虽有贼邪,弗能害也”。

现代研究发现,人体的免疫功能与中医的阳气概念有相似之处。阳气的温煦作用类似于代谢活动的正常进行。阳气充足,免疫功能正常,新陈代谢旺盛,肌体能量才能供应充足。王永炎院士提出“阳(气)虚化风”的思想论治中风病,指出阳气不足同样可以引起气血运行失常,可以补虚扶正、益气活血为主,佐以理气活血、化痰通络等治疗方法治疗中风及中风后疲劳^[10]。董波教授临证注重五脏阳气的重要性,从五脏阳气论治胸痹心痛,拓展了对胸痹心痛病的辨治思路^[11]。此外,阳气不仅仅体现在生理层面,还包括心理层面的健康,阳气充足则精神振奋。吴节教授采用扶阳疗法治疗阳虚型抑郁患者,主张“扶阳气,神得养”的理念,通过药物及针灸治疗,扶助阳气,通调气机,对改善阳虚郁症患者症状有极大帮助^[12]。

2 类风湿关节炎的病因病机

《黄帝内经》指出:“痹者闭也”,认为痹病的致病因素首先主要是人体气血瘀阻,引起经脉不通而导致的,筋脉不通则血液运行受阻,四肢失去濡养,故发为痹证。究其病因,《黄帝内经·素问》指出:“风寒湿三气杂至,合而为痹也,其风气胜者为行痹,寒胜者为痛痹,湿胜者为著痹也”。风寒湿是外感六淫邪气中常见的三种邪气,风、寒、湿三种邪气侵袭人体后,滞留肢体、关节、筋肉,以致经络闭塞不通,经

脉不行而致痹症,并且根据致病邪气的不同,所引起的症状也不同,风性善变,游走不定,根据其致病特点,若风邪偏重,称为“行痹”;寒性收引,凝结阻滞气机,经脉不通则痛,故若寒邪偏重,称为“痛痹”;湿性重浊,湿性粘滞,若湿邪侵袭人体,则可见肌肤不仁,重着疼痛等,故若湿邪偏重,称之为“着痹”^[13]。除感受外邪外,痹症的发生也与人肌体的内在因素有关。《黄帝内经·灵枢》指出:“风雨寒热不得虚,邪不能独伤人”,如果人体不得虚邪之气,外感风雨寒热是不能单独伤害人体的;所以久病体虚之人,或劳逸不当,将息失宜,精气亏虚,肢体筋脉失养,以致外邪乘虚而入。此外,导致痹证的发生还与营卫失调、脏腑失和有关。《素问·痹论》中曰:“逆其气则病,从其气则愈,不与风寒湿气合,故不为痹”,这里的“逆其气”指的就是营卫失调,说明痹病的发生发展中与营卫之气的强弱和失调与否也有很大关系。马蒨进一步认为:“所以成痹者,以其内伤为本,而后外邪得以乘之也”。由此可以看出,虽然外感六淫,尤其是“风寒湿”三邪是痹病发生的主要因素,但正气强弱、气机运行和荣卫调和这些内在因素在痹病的发生与发展中也举足轻重。方剑乔教授基于“痰、瘀、虚交错”的病机,通过针灸与药物结合以调和气血、祛风除湿、滋阴清热、通络止痛。孙西庆教授以调和阴阳为基本原则,主张从五脏阳气论治,重视温阳、通阳药物的应用,均达到缓解症状的效果,取得良好的临床疗效^[14-15]。

3 “重阳”思想在类风湿关节炎中的应用

《素问·生气通天论篇》指出:“凡阴阳之要,阳密乃固”,人体内在阴阳的平衡和谐之要,在于阳气的固密。如《素问·阴阳应象大论篇》:“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也”,阴气主静,阳气主动,只有阳气充盛,维持阴阳之间的平衡,才能保持肌体生理功能的正常进行,凸显了卫阳之气在防御肌表、荣养四肢关节筋骨中的重要作用;《素问·生气通天论篇》指出:“阳气者……柔则养筋”,只有阳气充足,肢体关节,肌肉筋骨才能有所充养。正如郑钦安在《医理真传》所言:“阳气无伤,百病自然不作,有阳则生,无阳则死”^[16]。阳气不足者,无法抵御风寒,导致寒凝气聚,病邪存于经脉肌表,累及筋骨、肌肉、关节。迁延日久,若外邪入深,经脉失养,阻碍气机,耗伤气血,血气不至,则肌肤不仁,皆因阳气不足所致。除此之外,在痹病的发展过程中,痰浊、瘀血和水湿等一些病理产物的产生与肌体阳气不足、卫外不固也

有很重要的关系。《素问·评热病论篇》：“邪之所凑，其气必虚”，也正如后世医家指出“痹久必有痰湿败血瘀滞经络”，皆阳气卫外不固，痰浊血瘀与外邪相合，闭阻经络，导致脏腑功能失常，津液失于输布，水湿痰瘀停聚局部，导致病症迁延日久，病程漫长难愈。

田雪梅主任基于“重阳思想”认为阳气不足是类风湿关节炎的发病基础。而病理关键在于“阳化气，阴成形”功能失调。针对阳虚不化、阴毒积聚而引起的寒湿、痰浊、瘀血等病理产物停聚于人体筋骨关节，在“温阳化气”的基础上辅以“通阳祛邪”，兼顾“阳化气”不足与“阴成形”过盛，达到“温阳”与“通阳”相辅相成之功效^[17]。《中藏经》指出：“阳者生之本，……阳宜长益，顺阳者生，逆阳者死”。若阳气充足则卫气充盈，虽感外邪但不成痹。故在治疗或预防时，要注意顾护肌体的阳气。病位较浅的要注意及时祛邪，病位如果偏于深重，要及时注意扶正，同时治疗时不要过度使用补益的药物，以免留邪。在治疗类风湿关节炎时，针对风、寒、湿致病因素的不同选择不同的治法，因其风寒易去，湿邪难消，治疗时勿损元气。在组方用药时，可适当搭配茯苓、白术等药物顾护脾胃，或配以人参、肉桂益气助阳，或搭配理气药物去扶肺肾脾胃之气，以达到“先天未受邪之地”之意。治湿的同时不伤阳气，同时防止病邪入里，藏邪予内。

4 典型病案

李某，男，56岁，普通工人，初诊日期：2023年10月27日，主诉：双手关节肿痛伴晨僵六月余。患者六个月前无明显诱因出现双手关节疼痛，早晨起床时双手僵硬，持续十分钟左右，活动后有所缓解，晚上疼痛加重，揉按或热敷后减轻，未就诊。近日疼痛加重，双手指关节活动不利，局部压痛、肿胀，无明显畸形。肢冷畏寒、腰膝酸软、倦怠乏力、食欲下降，无发热、盗汗等症状，精神可，大小便正常，舌质红，苔白，脉弦紧。既往无明显疾病史，家族中有类风湿关节炎病史。查体：手近端指关节、掌指关节肿胀，压痛明显，活动受限，关节外形未见明显畸形。实验室检查：血常规：白细胞计数正常，血红蛋白正常；类风湿因子(RF)：阳性；抗环瓜氨酸肽抗体(anti-CCP)：阳性；C反应蛋白(CRP)：轻度升高；红细胞沉降率(ESR)：轻度升高。X线示双手关节软组织肿胀，骨质疏松。心电图、心脏彩超等未见明显异常。

西医诊断：类风湿关节炎

中医辨证：痹症；风寒痹阻、肝肾不足证

治以温阳补肾，祛风散寒，选用独活寄生汤加减；

方剂：独活15g，川乌15g，桑寄生12g，制附子15g，桂枝12g，牛膝12g，鸡血藤12g，羌活12g，川芎9g，海桐皮9g，官桂6g，干姜6g，草豆蔻9g，甘草6g；

服3剂后复诊：双手疼痛肿胀减轻，原方加菟丝子12g，杜仲12g以加强温补肾阳之功，3剂后晨僵不适症状明显减轻。又7剂，关节功能恢复良好，症状基本完全缓解，逐渐减量。

按语分析：

患者家族中有类风湿关节炎病史，手近端指关节、掌指关节肿胀，压痛明显，活动受限，实验室检查示：类风湿因子阳性；抗环瓜氨酸肽抗体阳性；红细胞沉降率轻度升高；X线示双手关节软组织肿胀，骨质疏松；心电图、心脏彩超等未见明显异常；西医诊断为类风湿关节炎。患者年过半百，加之工作因素，肝肾不足，故见肢冷畏寒、腰膝酸软、倦怠乏力等，阳气不足，气血运行不畅，以致四肢失去濡养温煦，易受外感风寒侵袭，迁延日久以致双手指关节活动不利、疼痛、肿胀，舌苔、脉象均符合风寒痹阻、肝肾不足之象。根据《黄帝内经》“重阳”思想，重视阳气的调养与外邪的防御是治疗类风湿关节炎的关键，治以温阳补肾，祛风散寒，选用独活寄生汤加减。方中独活、川乌、羌活、鸡血藤、海桐皮祛风散寒、通络止痛，合为君药；制附子、牛膝、桑寄生、官桂补肾益精、强筋骨，同为臣药；桂枝、川芎、干姜、草豆蔻温阳散寒、行气止痛，共为佐药；甘草调和诸药为使药。全方共奏温阳补肾，祛风散寒之功。二诊时患者疼痛肿胀减轻，加菟丝子、杜仲以加强温补肾阳之功，随后症状基本完全缓解，逐渐减量。通过温阳祛湿、活血化瘀的治疗思路，既能缓解疼痛症状，又能从根本上改善关节的功能状态，此案充分体现了中医药在类风湿关节炎治疗中的独特优势。

5 总结

中医认为，类风湿关节炎的发生多由风、寒、湿、热等邪气阻滞经络，导致肢体筋骨肌肉疼痛、肿胀或活动受限。但究其病因病机，阳气不足在其产生、发展和转归中占有重要因素。阳气不足，肌体运行阻滞，气血生化失调，正虚不能抗邪，迁延日久，感病情进一步加深，阴阳失衡，脏腑受损。在治疗过程中，

不仅要专注于祛除外邪更要注重肌体正气的防护。此病病因复杂,病症繁多,治疗时还需辨明病因,辨清病症,对症治疗,方能取得良好的疗效。

参考文献

- [1] BROWN P, PRATT A G, HYRICH K L. Therapeutic advances in rheumatoid arthritis[J]. BMJ, 2024, 384: e070856
- [2] ALIVERNINI S, FIRESTEIN G S, MCINNES I B. The pathogenesis of rheumatoid arthritis[J]. Immunity, 2022, 55(12): 2255-2270
- [3] DIAZ-GONZALEZ F, HERNANDEZ-HERNANDEZ M V. Rheumatoid arthritis[J]. Med Clin (Barc), 2023, 161(12): 533-542
- [4] SZEKANECZ Z, BUCH M H, CHARLES-SCHOEMAN C, et al. Efficacy and safety of JAK inhibitors in rheumatoid arthritis: update for the practising clinician[J]. Nat Rev Rheumatol, 2024, 20(2): 101-115
- [5] 姜泉. 实用中医风湿免疫病学[M]. 北京:中国中医药出版社, 2022:56
- [6] 和琪, 陈继鑫, 周沁心, 等. 基于“阳主阴从”观辨《内经》和《仙授理伤续断秘方》中扶阳思想[J]. 河北中医, 2024, 46(8): 1374-1377
- [7] 钟永圣. 黄帝内经选解[M]. 北京:新华出版社, 2018: 28
- [8] 黄永福, 黄飞翔. 张仲景重阳思想在高血压治疗中的应用[J]. 国医论坛, 2024, 39(4): 1-3
- [9] 成西, 郭雨晴. 从中国哲学“重阳”思想探讨“火神派”理论源流[J]. 中国中医基础医学杂志, 2020, 26(5): 638-639
- [10] 马鹏珍, 古金晓, 杜雨轩, 等. 基于王永炎教授“阳(气)虚化风”理论探讨中风后疲劳[J]. 环球中医药, 2023, 16(12): 2525-2528
- [11] 高屹曼, 董波. 浅谈董波教授从五脏阳气论治胸痹心痛经验[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2024, 22(7): 1336-1338
- [12] 李吴雨, 吴节. 吴节教授从“阳、气、湿”三因治疗郁证经验[J]. 成都中医药大学学报, 2024, 47(2): 71-74
- [13] 范永升. 中西医结合临床风湿病学[M]. 北京:中国中医药出版社, 2021:31
- [14] 张全爱, 李晓宇, 张奇文, 等. 方剑乔教授针药结合治疗类风湿关节炎的临床思辨特色与治疗经验[J]. 浙江中医药大学学报, 2023, 47(06): 608-612
- [15] 王哲, 孙西庆. 孙西庆教授从五脏阳气论治痹证经验[J]. 现代中西医结合杂志, 2021, 30(09): 959-962
- [16] 卜俊成, 卢昊霖, 卢晓峰, 等. 河南孟州卢氏温阳通脉学术流派与临证经验[J]. 河南中医, 2024, 44(2): 212-216
- [17] 李喜媛, 雷海桃, 马麦丽娜, 等. 田雪梅主任医师基于“重阳思想”论治类风湿关节炎[J]. 风湿病与关节炎, 2024, 13(7): 30-34

责任编辑:段金卯